

Advanced Laparoscopic Bariatric Surgery Centers

مراكز جراحية متقدمة لعمليات السمنة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

Dear patient:

The IMC Bariatric Surgery Team wishes you good health and wellness and we are soliciting your attention to the following information which is significant to your health. It has been proven that Bariatric Surgery is effective solution to treat obesity and its related co-morbidities, particularly for patients who comply with the post-operative instructions and committed for regular follow up in the outpatients. The following are the possible complications related to the bariatric surgery as it was discussed with you prior to the procedure by your physician. As a patient, you have the full right to ask for more information regarding the coming points in case further clarification was needed

Firstly: The following are the complications attributed mainly to the Obesity surgeries in general :

1. Deep vein thrombosis, pulmonary embolism and portal vein thrombosis in about 1-2%.
2. Chest infections; mainly in heavy smokers and elderly patients.
3. Superficial thrombophlebitis mainly at the site of cannula insertion in less than 1% cases
4. Possible post-operative ICU admission for additional respiratory support and monitoring for patient known with sever pre-operative sleep apnea condition as well as a routine application of CPAP or BiPAP post operatively during admission.
5. Wound infections are normally minor after bariatric surgery procedure.
6. Rapid weight loss which may induce gallstone formation.
7. Fluid and electrolyte disturbances which can be resolved by administration of IV solutions and mineral supplements and in case of severe electrolyte disorder patient may need admission.
8. Rhabdomyolysis (muscle break down) caused by extensive pressure on the muscles during the surgery. It is often treated conservatively at its early stage by IV medication, diuretics, and monitoring in ICU. However,

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

☐ نعم ☐ لا

☐ نعم ☐ لا

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضر ؟

عزيزي المريض:

تتمنى لك أسرة المركز الطبي قسم جراحات السمنة والمناظير المتطورة الصحة والعافية.
الرجاء الإطلاع على هذه المعلومات التي قد تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحالتك. حيث أن عمليات السمنة أثبتت فعاليتها واستفادة المرضى منها بشكل جيد وذلك بمتابعة المرضى الذين أجروا هذه العمليات والتزموا بالمتابعة بالعيادات الخارجية بشكل منتظم حسب الإرشادات والتعليمات وذلك لإجراء الفحوصات الروتينية والمتابعة الدورية.
وفيما يلي المعلومات عن المضاعفات التي قد تصاحب أو تحصل نتيجة عمليات السمنة التي تمت مناقشتها معك والمعدة لك كتابيا حيث يحق لك الاستفسار عن أية معلومة غير واضحة وذلك لايماننا بأن للمريض الحق بمعرفة أدق التفاصيل عن العملية التي سوف يجريها قبل إجرائها.

أولاً: المضاعفات العامة بسبب عمليات السمنة بشكل عام :

1. الجلطات العميقة في الأوردة ، وجلطات الرئتين وجلطات الوريد الباطني تتراوح بين 1-2%.
2. التهابات الرئتين :علما بأن لها علاقة مباشرة بالتدخين و المرضى المسنين.
3. التهابات الأوردة السطحية من جراء تركيب القسطرة الوريدية لأخذ الأدوية والمحاليل في أقل من 1%.
4. المرضى الذين يعانون من إنقطاع النفس أثناء النوم نتيجة السمنة المفرطة قد يتطلب دخولهم الى العناية المركزه لدعم التنفس او المراقبة الدقيقة على الأقل لمدة 24 ساعة ، وهم بحاجة أيضا الى قناع الهواء المضغوط بعد العملية بشكل روتيني.
5. التهابات الجروح وهي في العادة بسيطة بعد عمليات جراحة المناظير.
6. النزول السريع للوزن يمكن أن يساعد على حدوث ركود في عصارة المرارة وتكون رمل أو طمي التي تؤدي في الغالب الى حصوات في المرارة.
7. إختلال السوائل والمعادن ويتم علاجه بالمحلول الوريدي وتعويض الناقص من المعادن وحتى التنويم في المستشفى في الحالات الحادة.
8. إنحلال الربيدات الناتجة عن تكسر العضلات خاصة في حالة الأوزان العالية والعمليات الطويلة .عادة يتم اكتشافها مبكرا أثناء العملية أو بعد العملية مباشرة حيث يبدأ العلاج بالمحاليل الوريدية ومدرات البول

patient may requires dialysis in severe cases.

9. Peripheral neuropathy caused by compression of the limb nerve particularly in patients with excessive overweight and during long surgical procedure.
10. Mortality rate is insignificant; about one in a thousand.
11. In some cases, Gastric bypass surgery can be changed to sleeve gastrectomy based on the following intra-operative findings: sever bowel adhesion or difficult anatomy particularly in patients with extensive body weight.
12. In case of gastric band removal surgery, the removal of the band reservoir may be deferred to other separate session, mostly in 3-6 months.

Secondly: Bariatric surgery related complication

A. Short term (intra-operative or postoperatively)

1. Leak: 1-2 %, the condition occur when part of the digestive fluid leaks to the peritoneal cavity, either from the stapler line in sleeve gastrectomy cases or through the anastomosis site in bypass surgeries, which lead to serious derangement in the vital signs and other deterred complications requiring in many cases a re- intervention with other procedure according to the discretion of the treating physician.
2. Gastrointestinal bleeding in 1-2%. Post-operative bleeding is normally treated conservatively in 99% with supplying blood and blood components and only 1% of the cases require surgical intervention. In extremely rare condition, open surgery is required in case of severe injury of internal organs e.g. splenectomy in splenic injury.
3. Intestinal obstruction in gastric bypass surgery, in rare condition; 1 per thousand
4. Severe nausea which is usually spontaneously subsides in couple of days to one month.
5. Depression and is treated with antidepressants in no more than six months.

B. Long term complications:

1. Redundant skin, which in extreme cases may require plastic surgery intervention.
2. Dumping syndrome (Rapid Gastric Emptying) after gastric bypass surgery, manifested by tiredness, sweating, palpitation and occasionally diarrhea, following intake of diets with excess carbs or saturated and hydrogenated fats. This is mainly self-limited condition, it usually last for a

والمراقبة في العناية المركزة وفي الحالات الشديدة يحتاج المريض الى غسيل دموي كلوي.

9. إصابة الأعصاب الطرفية السطحية للأطراف السفلى عادة ما تكون نتيجة الأوزان العالية وفي العمليات الطويلة.
10. الوفاة ونسبة حدوثها واحد في الألف تقريبا.
11. في حالة عمليات تغيير المسار يكتفي بعمل عملية التكميم عند وجود التصاقات شديدة في الأمعاء او في حالات الصعوبة التشريحية نتيجة الأوزان الكبيرة جدا.
12. عند إزالة الحزام حول المعدة. في اغلب الاحيان يترك الخزان وذلك لتخفيف آلام بعد العملية بحث يزال لاحقا تحت بنج موضعي في فترة تتراوح ما بين ثلاث لستة أشهر ما بعد العملية

ثانيا : المضاعفات التقية من عملية السمنة بشكل خاص.

أ. المضاعفات القريبة (أثناء العملية أو بعد العملية مباشرة):

1. التسريب: بنسبه 1-2 % تقريبا حيث تتسرب السوائل من داخل الجهاز الهضمي للحيز الداخلي للغشاء البريتوني من خلال الدبابيس في حالات التكميم أو من احدى توصيلات الامعاء في حالات تغيير المسار والتي تؤدي الى اختلال في العمليات الحيوية للمريض ومضاعفات اخرى ويطلب في كثير من الأحيان التدخل بالمنظار الجراحي وعمل ما يراه الجراح مناسباً في كل حالة.
2. النزيف: بنسبه 1-2% تقريبا , وهي مثل أي عملية جراحية يحدث النزيف إما أثناء الجراحة ويتم معالجته في وقته وفي أحيان نادرة يستوجب تحويل العملية الى فتح بطن جراحي وفي حالات إصابة الأعضاء المجاورة كالحمل إصابة بالغة من الممكن أن تؤدي الى استئصاله هي حالة نادرة. أما في حالت النزيف بعد العملية فعادة يعالج بالعلاجات التحفظية في 99% من الحالات مع إعطاء الدم ومشتقاته ، وفي 1% من الحالات يستوجب التدخل الجراحي.
3. الإنسداد المعوي في واحد من الألف في حالات تغيير المسار.
4. الغثيان الشديد وعادة ما يتوقف بعد فترة أيام الى شهر.
5. الشعور بالإحباط والإكتئاب والذي يعالج بالأدوية وعادة لا يتعدى الستة أشهر.

ب. المضاعفات البعيدة :

1. الترهل وفي حالات تستدعي عمل العمليات التجميلية.
2. متلازمة التفريغ المعوي وهي الإحساس بالتعب مع الرغبة في النوم مع التعرق الشديد والخفقان السريع وأحيانا الإسهال وذلك في حالة تغير المسار بنسبة كبيرة وفي بعض حالات التكميم اذا أفرط المريض في أكل الدهون المشبعة والمهدرجة والنشويات البيضاء والسكريات المعقدة وعادة ما تختفي بعد أشهر و تستمر أحيانا لمدة سنتين.

couple of months to two years.

3. Weight regain or inadequate weight loss. This complication could be mainly attributed to the unhealthy diet plan the patient may follow postoperatively such as consumption of an excessive saturated fatty foods and complex carbohydrates.
4. Hair loss: mainly related to low protein intake, usually last for 4-6 months before it spontaneously stop.
5. Acute inflammation of the gallbladder due to stone formation and this is due to chronic dehydration or rapid weight loss.

C. Gastrointestinal Complications

1. GERD (gastro esophageal reflux disease) in 5% may warrant other procedure e.g. Gastric bypass if failed to manage conservatively.
2. Diarrhea, particularly in distal gastric bypass surgery and single anastomosis gastric bypass.
3. Formation of Intra-gastric ulcers or ulcers close to the gastrointestinal anastomosis area, particularly due to smoking or during the consumption of anti-rheumatic medication and NSAID without considering necessary precaution measures such as routine antacids medication which can mitigate the harmful effect of these medications on the stomach wall.
4. Occasional stomach and bowel movement disorder that causes laziness in its function. It is usually self-limited.
5. Intestinal obstruction in post gastric bypass surgery is caused by internal herniation. The condition is manifested by severe abdominal pain after eating and drinking, nausea and vomiting. The condition can be diagnosed by CT and early surgical intervention is mandatory to amend the condition.
6. Malnutrition
7. Risk of multivitamins and micronutrient deficiency if there is no adequate compliance with the instructions given regarding the post-operative supplements.

Gastric Banding Complications:

1. Slippage of the gastric band resulting in partial or total gastric blocking that require band deflation and in some cases removal or reposition of the band.

3. إستعادة الوزن أو عدم نزوله بشكل كافي أو ثباته مبكرا قبل تحقيق النزول الكافي. في الغالب توجد علاقه وثيقه مع نظام غذائي غير صحي كالإفراط في الدهون المشبعة والمهدرجة والنشويات البيضاء والسكريات المعقدة.

4. تساقط الشعر وهي ظاهرة تحدث عادة في حالات عدم تناول البروتينات سواء كان مصدرها النباتي أو الحيواني وعدم تناول مكمل البروتين بشكل كافي. تستمر هذا المشكله من 4 - 6 اشهر وتتوقف بعدها تلقائيا في الغالب.

5. احتمالية تهيج المرارة وحدوث التهابات مزمنة بها بسبب تكون الحصوات و ذلك بسبب الجفاف المزمن والنزول السريع للوزن

ج. المضاعفات المتعلقة بالجهاز الهضمي :

1. الغثيان والترجيع أو الإرتجاع الحمضي في 5% من حالات التكميم عادة ما يتطلب تدخل جراحي اخر (تغيير مسار) اذا فشل العلاج بمضادات الحموضة.

2. الإسهال غالبا في حالات تغيير المسار المتقدم أو تغيير المسار ذو التوصيله الاحاديه

3. التقرحات داخل المعدة وبجوار توصيل المعدة بالأمعاء التي تزيد مع التدخين أو عند استخدام المريض علاجات الروماتيزم والمسكنات من نوعية NSAID مثل البروفين، الفولترين، الأديل أو السيرليكس بالإضافة لعدم أخذ أدوية المعدة التي تعطى بشكل روتيني ووظيفتها الأساسية حماية بطانة المعدة من التقرحات وهيجان المعدة الناتج من مثل هذه الأدوية .

4. حالات كسل وخمول حركة المعدة أو الأمعاء وعادة تتحسن مع الوقت (من أيام وتمتد في بعض الأحيان الى أسابيع أو أشهر وتحتاج في بعض الأحيان الى علاجات ومغذيات).

5. الفتاقات الجراحية الداخلية في حالات تغير المسار وذلك بعد فترة من نزول الوزن وتبدأ كأعراض اشتباه انسداد معوي وهي كالآتي: آلام باطنية مزمنة لفترات متقاربة مثل الإمساك أو المغص المزمن خصوصا بعد الوجبات وقد تصل لإنسداد معوي مع ترجيع مزمن والام حادة بالبطن وإمساك مزمن. يمكن تشخيصها بالأشعة المقطعية وفي الحالات الشديدة ممكن أن يؤدي الى نقص التروية الدموية للأمعاء مع احتمال الغرغرينة في الأمعاء والحاجة لعملية جراحية طارئة لعمل اللازم.

6. سوء التغذية .

7. خطوره فقدان الفيتامينات والمعادن المهمه من الجسم خاصه اذا لم يمتثل المريض للارشادات المقدمه اليه بخصوص تناول الادويه اللازمه لمنع حدوث ذلك في الفتره مابعد العمليه.

المضاعفات المتعلقة بربط المعدة :

1. التفاف الحلقة في الجزء العلوي من المعدة مما يؤدي الى انسداد جزئي أو كلي للمعدة والذي يتطلب توسيع الحزام أو في حالت معينة إزالة

Patient's Name : _____

MRN : _____

2. Gastric erosion which is not common but requires removal of the band and repair of erosion.
3. Esophageal extension
4. Reservoir and tube complications such as leak, disconnection.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and adequately addressed to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

D. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-

الحزام ان تطلب الأمر ذلك.

2. تآكل جدار المعدة وهو غير شائع ولكن علاجه يستدعي إزالة الحزام وإصلاح المعدة أو في بعض الحالات المتضاعفة المتقدمة عمل تكميم للمعدة أو حتى تغيير مسار.

3. توسع المريء وهو غير شائع لكن يتم إصلاحه بإزالة الحلقة

4. المضاعفات المتعلقة بالخزان أو الأنبوب الواصل بين الخزان والحلقة مثل (التسريب أو انفصال أو انقطاع الأنبوب أو الإلتهاب الموضعي المزمن). يتم إصلاحها بسهولة في حالة حدوثها وان استدعى التدخل بالمنظار الجراحي.

لقد تم إعطائي ورقة معلومات المريض التالية:

- تمكنت من طرح الأسئلة وإثارة المخاوف مع الطبيب بشأن حالتي ، والتحقق المقترح ومخاطره ، وخيارات العلاج. لقد تمت مناقشة أسئلتي ومخاوفي والإجابة عليها بما يرضيني.
- أفهم أنه بحق لي أن أغير رأيي في أي وقت ، بما في ذلك بعد التوقيع على هذا النموذج ولكن يفضل بعد مناقشة مع الطبيب.
- أفهم أنه قد يتم تسجيل الصورة / أو لقطات الفيديو كجزء من تحقيقاتي وأثناءها وأن هذه الصورة أو الفيديو ستساعد الطبيب في توفير العلاج المناسب.

على أساس البيانات أعلاه ،

أطلب الحصول على الإجراء

اسم المريض:

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى غير القادرون على تقديم الموافقة :

يجب الحصول على موافقة من شخص بديل لإتخاذ القرار في الترتيب أدناه.

اسم الشخص البديل متخذ القرار :

التوقيع:

علاقته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

ب- بيان الطبيب / المفوض

لقد شرحت للمريض جميع النقاط المذكورة أعلاه تحت قسم موافقة المريض (G) وأنا من الرأي القائل بأن المريض / صاحب القرار

Patient's Name : _____

MRN : _____

maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name:

Signature:

Date: Time:

2) Name:

Signature:

Date: Time:

*(For female patients) "No needs for pregnancy test."

Signature:

Date/Time:

البدیل قد فهم المعلومات.

اسم الطبيب / المفوض :

التخصص :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

الشهود (على التوقيع أعلاه)

(1) اسم :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

(2) اسم :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

* (بالنسبة للمرضى الإناث) " لا داعي لإجراء تحليل الحمل "

التوقيع :

التاريخ والوقت :